

25 - 07-L'inspection et la palpation - Pr A. BENJELLOUN

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa s-salamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi ajma'in, chers étudiants. Nous allons continuer notre série de cours sur la séminologie respiratoire. Nous allons attaquer maintenant l'examen clinique, l'examen physique pleuropulmonaire.

Le premier cours concernant l'examen physique concerne l'inspection et la palpation. Tout d'abord une introduction, l'inspection du thorax, l'inspection du cou et puis la palpation du thorax et du cou. L'examen respiratoire, c'est d'abord l'examen physique du thorax par inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation dans cet ordre.

Et puis il faut également un examen extratoracique ciblé. Donc l'examen du cou, des membres, des erganglionnaires à la recherche de signes liés à la pathologie. La démarche doit être précise.

Tout d'abord il faut chercher les signes de gravité, la première des choses. Après on effectue l'inspection, la palpation et puis suivi de la percussion et l'auscultation. Il faut toujours comparer avec la normalité.

Comparer le haut avec le bas et la droite avec la gauche. C'est comme ça qu'on va repérer les anomalies. Et puis il faut intégrer le tout dans un contexte général.

Tout d'abord l'inspection. La première des choses qu'il faut regarder c'est la posture de votre patient. Une posture normale, le thorax est en position verticale, neutre, assis ou debout.

Vous vous observez vous même quand vous êtes assis au bord du lit. Vous êtes normal, vous ne mettez pas vos mains sur le lit. Vous êtes donc en position verticale, neutre.

Chez les sujets BPCO ou chez les asthmatiques sévères, vous pouvez avoir comme signe de distanciation thoracique ce qu'on appelle le tripode. Quand vous voyez chez ce patient, il y a un appui sur les membres supérieurs ou alors des mains sur les cuisses ou des coudes sur les accoudoirs. La tête rentrée dans les épaules, le buste penché en avant.

Cette position améliore l'action des muscles respiratoires accessoires parce que le diaphragme à ce niveau-là n'est pas fonctionnel. Donc le patient est obligé de solliciter ses muscles respiratoires accessoires. La morphologie du thorax.

Normalement le thorax est grossièrement symétrique comme la droite ou la gauche. Il s'agit d'un tronc de cône ouvert en haut. Les arcs antérieurs des côtes sont obliques de haut en bas et d'arrière en avant.

Ce que vous voyez ici c'est les arcs postérieurs. Ici c'est les arcs antérieurs donc de haut en bas et d'arrière en avant. Le rapport entre le diamètre antéropostérieur et transversal est de 1,5.

Si vous mesurez le diamètre antéropostérieur, il doit être la moitié du diamètre transversal.

Lorsque les diamètres se rapprochent ou ils sont égaux, c'est ce qu'on appelle un thorax autonome. C'est un signe de bronchopneumonie.

Il y a des anomalies qui sont liées au développement de la cage thoracique, heureusement qui sont rares. Ici c'est ce qu'on appelle un pectus excavatum, un thorax en entonnoir. C'est une dépression du sternum avec protrusion postérieure et c'est source en général d'une insuffisance respiratoire.

A l'inverse, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le pectus carinatum, le thorax en carène, une déformation inverse avec protrusion sternale antérieure. C'est aussi une cause d'insuffisance respiratoire. Comme anomalies, vous avez également la syphose, c'est une courbure anormale du rachis sur le plan antéropostérieur.

Vous pouvez avoir la scoliose, c'est une courbure anormale du rachis sur le plan latéral. Mais le plus souvent, vous avez une syphoscoliose. C'est une source fréquente de dyspnées et de douleurs thoraciques.

A l'examen clinique, vous pouvez la rechercher en mettant juste votre pouce sur la pointe des homoplaques. Si vos pouces sont asymétriques, c'est probablement une scoliose. Vous pouvez avoir des anomalies qui sont liées à l'impact d'une pathologie bronchopulmonaire sur la cage thoracique.

Et là, c'est surtout la BPCO. Vous avez plusieurs signes de distension thoracique. Vous avez une augmentation du volume pulmonaire.

Et là, le diamètre antéropostérieur devient presque égal au diamètre transversal. C'est ce qu'on appelle le thorax ontôme. Vous pouvez avoir une élévation du manubrium sternal.

Normalement, la distance entre le manubrium sternal et la pomme d'Adam, le cartilage thyroïde, est supérieure à 3 cm. Lorsqu'ils se rapprochent, lorsque c'est inférieur à 3 cm, c'est ce qu'on appelle le signe de Campbell. C'est un signe de distension thoracique.

Vous pouvez avoir des tumeurs de la paroi thoracique ou des abcès de la paroi thoracique. Ces tumeurs ou ces abcès peuvent vous déformer la paroi. Pour faire le diagnostic, on peut faire une biopsie ou une cytoponction directe.

Il faut regarder la dynamique de la respiration. La respiration normale est de 12 à 16 cycles par minute. Une inspiration suivie d'une expiration plus longue.

Il existe parfois un soupir. C'est une inspiration plus profonde. Les soupirs surviennent toutes les 10 à 15 minutes.

Il existe des rythmes respiratoires anormaux comme la polypnée, la bradypnée. Je vous invite à revoir le cours précédent sur la dyspnée. Il faut regarder l'augmentation thoracique, c'est-à-dire les

mouvements thoraciques lors de la respiration.

Une diminution ou une abolition unilatérale de la mobilité peut être due soit à une atteinte pulmonaire unilatérale, un imbitorax plus petit, des côtes plus obliques lors des réssections, des atélectasies, des pneumonies étendues. On peut avoir également une atteinte pleurale, un imbitorax plus grand, ou des côtes horizontalisées lors de pneumothorax ou des pleurises abondantes. On peut avoir une asymétrie.

L'asymétrie en général est plus visible en décubitus dorsal, en respiration profonde. C'est parfois difficile à avoir en position assise. Lors de l'inspiration normale, il existe une augmentation du diamètre antéropostérieur de l'abdomen.

Le ventre sort, ça veut dire que vous utilisez le diaphragme qui est le muscle aspiratoire principal. Il existe également une augmentation du diamètre transversal de la partie intérieure de la cage thoracique. Et ça, c'est aussi l'utilisation du diaphragme.

L'expiration normale, c'est un phénomène passif par relâchement des muscles aspiratoires. Il peut être également actif en mettant en jeu les muscles expiratoires comme les muscles abdominaux. Et en général, vous avez une diminution des diamètres abdominaux et thoraciques.

Là, vous voyez qu'à l'inspiration, vous avez une augmentation du diamètre transversal de la cage thoracique. À l'expiration, à l'inverse, vous avez une diminution de ce même diamètre transversal. Les anomalies dynamiques, tout d'abord l'expiration abdominale active.

C'est un signe de gravité en aiguë. Il peut se voir chez les BPCO de façon chronique. C'est-à-dire que lors de l'expiration, votre patient sort le ventre de façon excessive.

Ça veut dire qu'il n'utilise pas le ventre pour l'inspiration, mais il l'utilise pour l'expiration. Cela veut dire que ses muscles inspiratoires sont défectueux. Il existe la respiration abdominale paradoxale par dysfonction du diaphragme.

C'est un signe également de gravité. C'est une diminution du diamètre abdominal à l'inspiration, alors que normalement, il devrait augmenter. Et vous avez la respiration alternante qui alterne des mouvements normaux et des mouvements paradoxaux.

C'est également un signe de gravité. Là, vous avez le fameux signe de Hoover que tous les externes connaissent lors de leurs stages en pneumologie. C'est une diminution du diamètre transversal à l'inspiration au lieu de son augmentation.

Là, vous avez une augmentation lorsque vous avez un poumon normal. Et là, c'est une diminution à l'inspiration lorsque vous avez un signe de Hoover. C'est caractéristique du broncon enfisé.

Il a le tirage intercostal. C'est la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires, des muscles

intercostaux, mais également sternocléidomastoidien. Et vous avez ce qu'on appelle un volet costal qui fait suite à un traumatisme.

Ce sont des fractures étagées de côte. Et là, ce qu'on a fait, c'est un volet costal. C'est une espèce de fenêtre qui va entrer à l'intérieur du thorax lors de l'inspiration qui va donner un mouvement paradoxal.

Et là, c'est une urgence chirurgicale. Il faut regarder également l'aspect cutané et les parties molles. Rechercher les cicatrices chirurgicales ou traumatiques.

Une circulation veineuse collatérale, ce qu'on appelle le syndrome CAV supérieur. Lorsque vous avez une tumeur médiastinale qui comprime la veine CAV supérieure, vous pouvez avoir une gynécomastie, une hypertrophie des glandes mammaires chez l'homme. En général, c'est un phénomène paranéoplasique qui accompagne les cancers, surtout le cancer bronchi.

Il faut inspecter le cou. On peut avoir une visibilité anormale des muscles du cou. Une hypertrophie par mise en jeu prolongée lors de la BPCO.

Vous pouvez avoir un pouls respiratoire, une contraction phasique des muscles du cou à l'inspiration. C'est un signe de gravité. On peut avoir un creusement cisternal ou cuscliculaire par mise en jeu des muscles accessoires.

On peut avoir une turgescence des veines jugulaires externes. C'est une insuffisance cardiaque droite et donc un signe d'hypoxie. On peut avoir des déformations, des saillies, des tumefactions.

Et là, il faut examiner correctement le patient à la recherche de pathologies conglomérées, tumorales ou thyroïdiennes. Là, chez ce patient, vous voyez par exemple une visibilité anormale des muscles inspiratoires du cou. Les scalènes et les muscles sternocléidomastoidiens.

C'est un signe d'insuffisance respiratoire. Là, chez ce patient, on voit une turgescence des veines jugulaires externes. C'est un signe d'hypoxie.

Et là, vous voyez, ce médecin appuie sur son hypocondre droit pour faire ressortir ses veines jugulaires. Ce qu'on appelle le reflux hépatojugulaire. La respiration paradoxale abdominale se recherche une main sur le thorax et une main sur l'abdomen pour la perception des mouvements respectifs.

Si vous avez l'abdomen qui gonfle en inspiration, c'est une respiration normale. Si au contraire, il rentre, c'est une respiration paradoxale. Le point inspiratoire, il recherche avec le bout des doigts sur le scalène au niveau du cou pour percevoir la contraction phasique en inspiration.

Le signe de ouvert est évident chez le patient maigre. Mais chez le patient obèse, ça peut être un peu plus difficile. Il faut mettre les deux mains à plat sur la partie inférieure du thorax.

Et le signe de ouvert est positif si les deux mains se rapprochent à l'inspiration. Ça veut dire qu'il diminue son diamètre transversal thoracique. On va palper également la trachée.

Elle est un peu plus difficile à palper. Le cartilage trachéal médian est repéré en susternal immédiat. Normalement, il est immobile en inspiration.

Lorsque la trachée est déviée, il faut rechercher une pathologie médiastinale. Lorsque vous avez une descente inspiratoire de la trachée, c'est une descente du cartilage thyroïde, c'est la paume d'Adam, ça veut dire qu'il y a une dépression intrathoracique importante. La palpation va rechercher également les vibrations vocales.

Ce sont les principaux signes qu'il faut rechercher à la palpation. Ce sont des vibrations transmises par le parenchyme pulmonaire à la paroi thoracique lors de la parole. Et sont recherchées les mains à plat sur la paroi thoracique postérieure, demandant au patient de dire 33.

En arabe, c'est 44. Et vous comparez le côté droit et le côté gauche, ainsi que les sommets par rapport aux bases. Lorsque les vibrations vocales sont diminuées ou abonnées, il s'agit soit d'un pneumothorax, une pleurésie, une pneumonectomie ou un amphysème.

Lorsqu'elles sont augmentées, en général, c'est une condensation parenchymateuse, par pneumonie ou atélectasie. Lorsque vous avez un pneumothorax ou après, par exemple, un drainage thoracique, vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'amphysème sous-cutané, ici. C'est de l'air qui est sous-cutané.

Vous avez une crépitation neigeuse, ça s'appelle l'amphysème sous-cutané. C'est une présence d'air dans la paroi thoracique. C'est une sensation de crépitation neigeuse à la palpation.

Il peut survenir lors de pneumothorax, après un drainage thoracique, de pneumomédiastin ou de rupture bronchique. Cet amphysème sous-cutané peut s'évacuer par exciption. Vous mettez des petites aiguilles et vous appuyez sur la peau pour faire ressortir l'air de la peau.